PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE LA ROUGEOLE

PHASES DE LA MALADIE

Incubation silencieuse
Durée moyenne 10 à 14 jours

Invasion avec catarrhe fébrile
Durée 4-5 jours
Sujet contagieux

Phase d'état = Eruption
Durée 4-5 jours
Sujet contagieux

SYMPTOMES

Aucun

Forte fièvre, rhinorrhée, toux, conjonctivite. Les douleurs abdominales, la diarrhée ainsi que les vomissements font aussi partie des symptômes.
Signe de Köplick (inconstant et < 24h) : énanthème = apparition sur la muqueuse buccale, à la hauteur des molaires, de petites taches rouges irrégulières avec un petit point central blanc.

Apparition progressive de petites plaques rouges de quelques millimètres de diamètre. L'éruption débute sur le visage, derrière les oreilles, puis s'étend progressivement sur 4 jours à tout le corps en commençant par le cou, et la partie supérieure du thorax. La fièvre reste élevée.

DIAGNOSTIC

Clinique : Voir symptômes

Biologique : Le J0 s'entend à partir de la phase d'état (éruption)

Écouvillonnage nasopharyngé

J0 -j7
RT-PCR, génotype

Sur milieu de transport virologique

Stocker et transporter à +4°C dans les 24-48h

Prélèvement salivaire

Tamponner la gencive (entre la joue et la gencive) pendant 2min

Le kit salivaire Oracol® est mis à disposition par l'ARS de votre région

J0 -j7
RT-PCR, génotype

J3 -j28
IgM et IgG salivaire

Fiche renseignements cliniques !!!
cliquez !

Stocker et transporter à température ambiante

Sérum

Technique de référence en l'absence de vaccination dans les 2 mois

J3 -j28
IgM

J0 -j17 puis
IgG 2ème prélèvement 10 à 20 jours après

Séroconversion ou **x4 entre les 2 prélèvements**

Stocker et transporter à +4°C

Urines

Technique alternative, utile en cas de difficulté pour réaliser un prélèvement de nasopharynx ou salivaire

J0 -j10
RT-PCR, génotype

Stocker et transporter à +4°C dans les 24-48h

TRANSMISSION



- L'humain est le seul réservoir naturel
- Infection connue la plus contagieuse
- **Transmission respiratoire** de personne à personne (persiste jusqu'à 2h dans l'air et sur les surfaces après le départ du patient)

PRÉVENTION PRIMAIRE

Vaccination et sensibilisation aux signes cliniques des professionnels afin de mettre en place des mesures le plus rapidement possible.

Vaccination efficace = 2 doses, dont la 1ère après l'âge d'un an

Un cas isolé peut parfois être le point de départ d'une épidémie !
Période de contagiosité : 5 jours avant et 5 jours après le début de l'éruption

Tout sujet présentant une éruption cutanée fébrile caractéristique doit être considéré comme un cas potentiel

Précautions standard + Précautions complémentaires respiratoires
Durée : jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption cutanée

Le personnel prenant en charge un cas suspect ou confirmé de rougeole doit être immunisé
Maladie objectivée ou **vaccination complète : 2 doses de vaccin après l'âge de 12 mois**

→ **Si le cas est un personnel :** éviction immédiate pendant la phase contagieuse - Contact Médecine du travail.

IDENTIFIER LES CONTACTS

Personnes ayant fréquenté de manière concomitante les mêmes locaux que le malade ou dans les 2h qui ont suivi son passage.
Période de contagiosité : 5 jours avant et 5 jours après le début l'éruption cutanée.
Contacts à risque de forme grave :

- la femme enceinte non vaccinée et sans antécédent de rougeole
- le sujet immunodéprimé
- les nourrissons de moins de 12 mois

MESURES POUR LES PERSONNES IDENTIFIÉES

Informer les contacts sans délai (EOH/ médecine du travail/ direction)
Rattrapage vaccinal : s'il est réalisé dans les 72 h après le 1er contact avec le cas, il peut éviter la survenue de la maladie.
En cas d'apparition de signes cliniques : téléphoner avant de consulter et avertir de la suspicion de rougeole (pas de salle d'attente).
Contacts à risque de forme grave : administration IG polyvalentes dans les 6 jours après l'exposition, discuté au cas par cas.

INFORMATION DÉCLARATION

- Effectuer un signalement immédiat à l'EOH, au médecin coordonnateur/ direction pour les EMS
- Informer l'ensemble du personnel du service
- **Déclaration obligatoire** pour toute suspicion de cas de rougeole



- **Toute suspicion de rougeole doit être déclarée sans délai à l'ARS**



Accès page internet ARS Grand Est signalement :

L'information de la mise en place des précautions complémentaires respiratoires doit figurer dans le dossier de soins, sur le planning de soins infirmiers, sur la porte de la chambre, et le cas échéant, sur les fiches de liaison et de transfert.

CHAMBRE

- Chambre seule (maintien en chambre obligatoire), porte fermée
- Aération biquotidienne de la chambre (au moins 15 minutes)
- Accès aux plateaux techniques : hors présence de patients et respecter les précautions complémentaires respiratoires
- Port d'un masque FFP2 (à défaut un masque à usage médical) par le patient avant la sortie de sa chambre
- Limitation et encadrement des visites en respectant les précautions complémentaires respiratoires

TENUE



- Port d'un appareil de protection respiratoire FFP2, avant l'entrée dans la chambre
- Le retirer en sortant de la chambre, après avoir refermé la porte
- Elimination devant la porte de la chambre



MAINS



- D'une manière générale, respecter les précautions standard et l'hygiène des mains (avant et après tout contact avec le patient, entre deux soins avant et après la mise en place de gants)
- Friction hydroalcoolique après avoir retiré le masque FFP2

BIONETTOYAGE



- Nettoyage désinfection quotidien de l'environnement (sols, surfaces, sanitaires)
- Aération d'une heure minimum de tout local fréquenté par le patient/résident après son départ
- Bionettoyage à la sortie du patient/résident : avec le port d'un masque FFP2 et en aérant

MATÉRIEL



- Privilégier l'usage unique ou le matériel dédié

GESTION



- Vaisselle, linge et gestion des déchets circuits habituels

SERVICES SUPPORT



- Limiter les déplacements du patient/résident, lui faire porter un masque FFP2 (à défaut un masque à usage médical) dès qu'il sort de sa chambre
- Ne pas le faire séjourner en salle d'attente
- Accélérer la prise en charge
- Délivrer une information à l'ensemble du personnel et du laboratoire avant l'envoi d'un prélèvement

CPias Grand-Est
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ars Agence Régionale de Santé Grand Est

avril 2025